

Hanseníase · diagnóstico, PQT e contatos

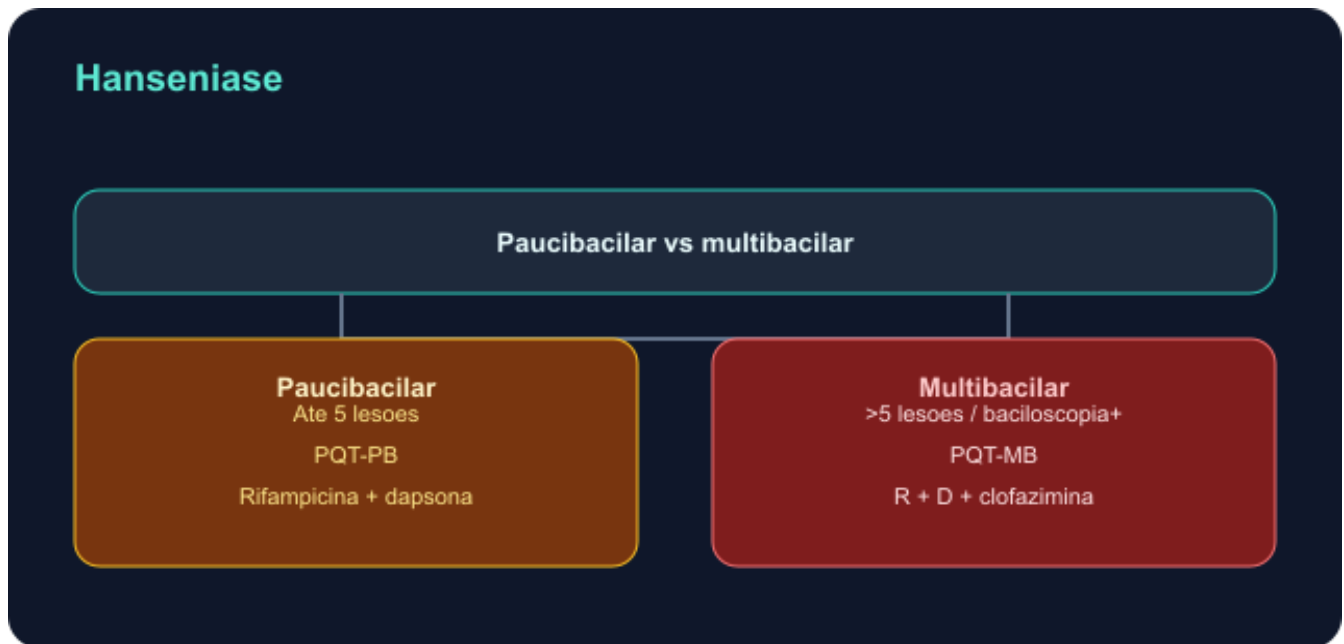
Hanseníase diagnostica-se clinicamente: lesão cutânea com alteração de sensibilidade e/ou nervo espessado. PQT cura; examinar contatos interrompe transmissão.

Achado-chave

Dica - Achado-chave

Hipostesia em placa hipocrômica/eritematosa é o clichê. Neural pura existe — avalie nervos periféricos (ulnar, tibial posterior etc.).

Número de lesões/carga bacilar define esquema de PQT e duração.



Conduta de vigilância

- Notificação compulsória; tratamento gratuito no SUS
- Exame de contatos domiciliares; BCG conforme protocolo de contatos
- Reações tipo 1 e 2: corticoide / talidomida (eritema nodoso) com regras estritas
- Prevenção de incapacidade: inspeção de pés, orifícios e fisioterapia

Diferenciais

Condição | Pista

Pitíriase versicolor | Sensibilidade normal
Tinha do corpo | Bordas ativas; KOH
Vitiligo | Acromia sem anestesia
Neuropatia diabética | Sem lesões típicas de hanseníase

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não isole o paciente sob estigma — após início da PQT a transmissão cai drasticamente. Gestante: ajustar esquema (evitar talidomida absolutamente).